

Fecha Última Actualización: 17-06-2023 10:33:11

Página 1 de 6

Información Paciente

Nombre : Hernan Jose Gonzalez Barreto
Edad : 34a 10m 15d
Dirección : Jose Tomas Urmeneta 801 Limache

Rut : 41.194.166-3
Fecha Nacto: 02/08/1988
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2200834
Sexo : Masculino
Teléfono : 964073544

N° Epicrisis
355472

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 11/04/2023 23:56

Días Estadía: 67

Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Egreso : 17/06/2023 10:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hidronefrosis Con Obstruccion Por Calculos Del Riñón Y Del U

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

INFORME DE TRASLADO 17/06/23

Nombre: Hernán José González Barreto
RUT: 41194166-3
Edad: 34 años
FI UTIM: 12/04/2023
FI SALA: 25/04/2023

ANTECEDENTES

· Médicos: Paciente crítico crónico: Politrauma en enero del 2022 por caída de altura con varias complicaciones (TEC Complicado: HSA traumática, contusiones cerebrales- Daño axonal difuso Grado 3, Neumotórax bilateral, fracturas costales, contusión pulmonar, Laceración hepática sin necesidad Qx. Fractura pelvis no desplazada consolidada. Fractura de muñeca manejada con ortesis. Osteomielitis sacra tratada
Litiasis renal bilateral.
· Quirúrgicos: derivados de politrauma.
· Fármacos: (-)
· Alergias: (-)
· Hábitos: (-)
· Hospitalizaciones recientes: HRS 13/01/22-21/04/2022 Politraumatizado Grave por caída de altura. Se encontraba en rehabilitación en Policenter desde su alta.

ANAMNESIS REMOTA

Paciente con traslado desde Clinica Policenter.

Paciente con historia que inicia el día 13 de enero 2022, realizando actividades laborales sufre caída de altura (3 pisos). Resultando en politraumatismo con Neumotórax (que requiere manejo en sitio del accidente).

Se traslada a SU de Hospital Padre Hurtado. Ingresa con compromiso de conciencia por lo que se decide manejar con IOT y VMI. Se realiza estudio de imágenes detectándose:

- Hemorragia subaracnoidea + hemorragia intracerebral

Fecha Epicrisis : 17/06/2023 10:33

Página 1 de 6

Fecha Última Actualización: 17-06-2023 10:33:11

Página 2 de 6

- Neumotórax izquierdo + Hemoneumotórax derecho
- Fracturas costales derechas + contusión pulmonar derecha
- Laceración hepática Grado IV
- Fractura de pelvis

Se realiza manejo inicial con pleurostomía bilateral además se carga con fenitoína y se administra suero hipertónico por sospecha de Hipertensión endocraneal (Eco de vaina de N. Óptico). Por hallazgos en TAC de cerebro, se decide traslado a Hospital Sotero Del Río. Evaluado por Neurocirugía, se desestima manejo quirúrgico, se instala captor de PIC. Se detecta en SU deformidad del antebrazo derecho. Por lo que se realiza Qx de urgencia para reducción de fractura radio-carpiana. Posteriormente se traslada a UPC para manejo.

Durante su estadía en UPC del HSR:

Con TAC grave, sin requerimientos de neuroQx, solo con manejo médico. Estuvo con captor de PIC pero 20/01, presenta desplazamiento por lo que se retira. Inicialmente con terapia con fenitoína, luego se cambia a levetiracetam. Sin evidencia de actividad epileptiforme, se decide decalaje hasta suspender (sin incidentes). Destaca en RM cerebral de control con daño axonal difuso Grado 3. Ingresa inicialmente con requerimiento de DVA con NE hasta 0,3 con posterior estabilidad y mejoría HDN logrando suspender el día 22/01. El 09/02/22, se realiza TQT por weaning frustrado

Infeccioso: Con múltiples HITs infeccioso durante su estadía en UPC.

- Inicialmente con NAVM por klebsiella MS, recibiendo ciprofloxacino. Posterior a ello con fiebre persistente, se plantea origen central por lo que se inicia manejo con cabergolina con buena respuesta.
- En febrero/22 nuevamente con alza de parámetros inflamatorios, se detecta NAVM por SAMR, por lo que recibe vancomicina. Evoluciona nuevamente febril y nuevo CAET (+) para SAMR, Acinetobacter Baumannii (ACBA), Klebsiella (KPN), ajustándose tratamiento según cultivos. Por persistencia de la fiebre, se realiza nuevo CAET con Klebsiella MR tratado con linezolid + Ceftazidima.
- Presenta nuevo cuadro infeccioso en marzo 2022 con CAET (+) para SAMR, KPN , ACBA, manejándose con vancomicina + Ampicilina sulbactam con buena respuesta.

Una vez estabilizado cuadro general, se decide su traslado a Policenter para seguir rehabilitación y manejo (Ingresando el 19/04/22).

Durante su estadía en Policenter se mantiene rehabilitación durante todo este periodo. Desde el punto de vista neurológico con TEC secuelado con daño axonal grado 3. Se maneja con equipo de psiquiatría y neurología. Con desajustes conductuales en contexto de deterioro orgánico. Se dan sugerencias de manejo las cuales se realizan en la actualidad. Desde el punto de vista respiratorio, inicialmente se deriva conT QT pero se logra rehabilitación y decanulación en septiembre de 2022.

Durante noviembre 2022 presenta cuadro de COVID, con deterioro clínico, pero sin necesidad de nueva IOT (solo manejo con VMNI)

Inicialmente se manejó con GTT pero logra una buena recuperación de deglución por lo que se retira en Octubre de 2022. Durante este último periodo y explicado por paratonía degenerativa con poca cooperación para alimentarse. Se decide instalación de SNG y rehabilitación fonoaudiológica.

Últimos HIT infecciosos en Policenter:

Escara sacra asociado a osteomielitis recibiendo tto atb prolongado con cotrimoxazol + Amoxic/ac clavulanico.

Presentó además cuadro de diarrea con Toxina CD (+) tratado con vancomicina oral con buena respuesta.

Última ITU 2° a KPN BLEE, manejado con amikacina por 7 días, sin ATB actual. Por itu a repetición se estudia, y presenta HUN a derecho secundario a en contexto de cálculo coraliforme incompleto recibe tratamiento con Meropenem.

Por esta razón se solicita traslado a HSR para resolución Qx por urología y así evitar cuadros de ITU recurrente. Pasa a la UTIM para seguimiento en espera de resolución por urología.

LABORATORIOS DE INGRESO HSR

12/04: hb 14.8, leucos 7440, plaquetas 254000, LDH 124, GSV: ph 7.348, HCO3 30.4, EBT 2.5, ELP 141/4.44/101, PCR 1.5, BUN 16.7, creatinina 0.93, ProtT 7.9, Mg 2, Ca 10.1, Albúmina 3.9, Urato 5.1, P 3.8, BiliT/BiliD 0.19/0.1, GGT 26, GOT 38, GPT 86, FA 125. SU: Orina inflamatoria, bacterias abundantes.

MICROBIOLOGÍA

12/04: Portación de Enterococo Van (-), KPC (+). Urocultivo (+) K. pneumoniae 100.000 UFC

Fecha Epicrisis : 17/06/2023 10:33

Página 2 de 6

Fecha Última Actualización: 17-06-2023 10:33:11

Página 3 de 6

IMÁGENES

12/04: PIELOTAC Signos de nefropatía crónica derecha Nefrolitiasis bilateral con cálculo coraliforme derecho. . Leve hidroureteronefrosis izquierda con cálculo en uréter distal. Litiasis vesical

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UTIM HSR.

Litiasis pieloureteral bilateral con HUN 2ria izquierda.

Politraumatizado grave por caída de altura

- HSA traumática, contusiones cerebrales- Daño axonal difuso Grado 3

- Neumotórax bilateral, fracturas costales, contusión pulmonar

-Laceración hepática sin necesidad Qx

-Fractura pelvis no desplazada con signos de consolidación

-Fractura de muñeca manejada con ortesis

TEC complicado

Paciente critico crónico

Osteomielitis sacra tratada

NAVM por Klebsiella tratada

ITU por KPN (Portación)

EVOLUCIÓN DURANTE ESTADÍA EN UTIM (12/04 al 25/04)

HDN: Clínicamente estable, bien perfundido. Sin requerimiento de DVA ni VDO. Sin conflicto.

Resp: Tranquilo, sin requerimientos de O2. Se mantiene KTR/KTM.

Infeccioso: Ingreso sin requerimiento de antibióticos. El 12/04 SO inflamatorio (sin CUP) y UC positivo para KPN 100.000 UFC, sin fiebre ni aumento de PPIs. Dado que se instrumentalizará la vía urinaria indicó ceftriaxona completando 5 días.

Renal: sin falla renal, crea 1.02, derivado para resolución de litiasis. En plan de resolución quirúrgica por equipo de urología, quienes solicitan nuevo pielotAC el cual evidencia (12/04): Signos de nefropatía crónica derecha, nefrolitiasis bilateral con cálculo coraliforme derecho, leve hidroureteronefrosis izquierda con cálculo en uréter distal y litiasis vesical. Se converso con urología para resolución, quedando a conocimiento del caso.

Nutrición: Estuvo con régimen enteral con fresubin y régimen cero por boca. Buena evolución clínica con terapia FNA, SNG ya retirada y con régimen oral (licuado + líquidos espesos).

Neurológico: Con secuela post TEC grave. Actualmente con cuadro de delirium hiperactivo. Se ajusta dosis de quetiapina a 50 mg- 50 mg- 100 mg el día 09/04 por indicación de psiquiatría. Se mantiene plan farmacológico y ambiental.

Dermato: dermatitis seborreica facial en manejo con ketoconazol en crema.

Rehabilitación: Se mantuvo en rehabilitación por kinesiología, fonoaudiología, con mejoría progresiva en movilidad y en deglución/comunicación.

EVOLUCION EN SALA MEDICINA (25/04 al 17/06)

Hemodinámico: Estable, autosostenido, bien perfundido. Normotenso con tendencia hacia la hipotensión que aparenta ser constitucional, asintomático. Se mantuvo solo con Monitorización no invasiva.

Respiratorio: Sin conflicto. Estoma de TQT cerrado. Se mantiene KNT R y M.

Nefrológico/ Urológico: Paciente con ureterolitiasis izquierda, evaluada por urología, se interviene quirúrgicamente (ureteroscopia) el día 08/05, sin incidentes, con buena evolución postoperatorio. Se realiza retiro sonda foley sin incidentes, presenta diuresis espontánea tras retiro. Nefrolitiasis derecha se diferirá. Sin falla renal actual.

Infeccioso:

·Paciente con bacteriuria asintomática por KPN MS, tratada con ceftriaxona 5/5 por intervención de la vía urinaria. Se controla el día 03/05 con UC (-) y sedimento urinario no inflamatorio.

·Por episodio único y autolimitado de diarrea, personal solicitó estudio CD; toxinas negativas, pero con antígeno de glutamato detectado. Como el paciente actualmente está asintomático, se difiere el tratamiento contra CD. Se mantiene aislamiento de contacto.

Nutrición / Rehabilitación:

-Nutrición: Régimen indicado por ANI: Licuado con líquidos espesados 1700 kcal + 65 grs proteína + pescado con puré + suplementos 1 vez al día. Seguimiento con parámetros nutricionales y función renal.

-Fono: Régimen licuado + pescado con puré + líquidos claros. Ingesta asistida, PAUSADA y sentado. Entregar medicamentos

Fecha Epicrisis : 17/06/2023 10:33

Página 3 de 6

Fecha Última Actualización: 17-06-2023 10:33:11

Página 4 de 6

molidos con semisólido (compota de frutas, agua espesa o licuado).

-KNT: Mal control de tronco, andador anterior (ESD° contenida al andador) y asistencia posterior moderada/máxima (carga peso hacia posterior) + refuerzo verbal (pierde la concentración). Mantener KNT full y uso de órtesis.

Neurológico: Con secuela post TEC grave y DAD grado III. Delirium resuelto, en tratamiento con quetiapina. Evaluado por neurocirugía, se decide mantener rehabilitación, se desestima continuar estudio con RNM Cerebro.

Dermatología: Paciente evaluado por dermatología, con diagnóstico de dermatitis seborreica en pecho y cuero cabelludo. Dermato sugiere tratamiento que no se ha podido iniciar por contexto socioeconómico de paciente e imposibilidad de comprar fármacos. Sugieren: Ketoconazol 2% shampoo, uso 3 veces por semana en cuero cabelludo y rostro. (Dejar actuar espuma 3-5 min y luego enjuagar). Salicort Loción o ungüento uso en placas de cuero cabelludo en la noche por 2 semanas. Terbinafina 2% crema, uso 2 veces por día por 2-3 semanas en placa de tórax.

Social: paciente inmigrante venezolano, con pareja e hijo, pero que no constituyen red de apoyo en Chile. Karina De Sa Mejias (esposa) 9 7824 6372

Profilaxis: Enoxaparina, PEG horario para optimización de deposiciones.

Aislamiento: Paciente con aislamiento KPC (habitación individual o cohorte) x 6 meses FI 13/04/2023, fecha término 13/10/2023. Considerar al momento de gestionar traslado. Se completa informe IAAS capredena.

ÚLTIMO LABORATORIO

13/06 FA 148, GGT 77, GOT 29, GPT 73. Ca 9.2, crea 1.02, BUN 20.1, Mg 2, prealbúmina 38.2, PT 7, PCR 2.8, hcto 38.5, hb 12.4, VCM 88.2, leucocitos 9640, plaquetas 250000, ELP 138/4.18/103, pH 7.395, P CO2 48.4, P O2 29.8, HCO3 29, T CO2 30.5, EBVT 4.1, sat O2

07/06 Covid/Influenza A/B (-), PCR 47.7, HCTO 39.3, Hb 12.9, VCM 87, Leucos 8510, plaquetas 257000, eritrocitos normales al frotis, leucocitos granulación tóxica +, plaquetas normales

CONDICIONES DE TRASLADO ACTUALES:

Paciente en buenas condiciones generales para condición neurológica crónica, normotenso, normocárdico, sin necesidad de O2 ni de medicamentos EV.

Con mejoría progresiva en movilidad con ayuda de terapias motoras, logra sentarse al borde de cama con buen control de tronco, aún requiere de apoyo de 2 personas para deambulación, con tendencia a lateralización.

En cuanto a funcionalidad, con ayuda de T. Ocupacional se logra trabajar memoria a corto plazo, alimentación con extremidad superior izquierda con buena respuesta.

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO

1. Paciente crítico crónico

2. Politraumatizado grave por caída de complicado - HSA traumática, contusiones cerebrales - Daño axonal difuso Grado III - Neumotórax bilateral, fracturas costales, contusión pulmonar. - Laceración hepática sin necesidad Qx - Fractura pelvis no desplazada con signos de consolidación. - Fractura de muñeca manejada con ortesis.

3. Dermatitis seborreica en pecho, cuero cabelludo

PLANES Y PENDIENTES

Se solicita traslado, con plan diferido de tratar urolitiasis derecha, estable del punto de vista neurológico y con necesidad de continuar con neurorrehabilitación. Al alta realizar interconsultas ambulatorias para: Neurología, dermatología y urología (por litiasis).

INDICACIONES ACTUALES

Régimen: Régimen licuado con líquidos claros asistido 1700 kcal + 65 grs proteína + pescado con puré + suplemento. Asistido, PAUSADO y sentado.

Reposo: semisentado, movilizar y levantar asistido

Oxígeno: SOS para Sat O2 92%.

Rehabilitación: KNT M y R, FNA, T.O.

HGT AM.

Prevención de caídas y LPP, contención física SOS, aseo bucal cada 8 horas

INVASIVOS: no

Fecha Epicrisis : 17/06/2023 10:33

Página 4 de 6

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:56

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 17-06-2023 10:33:11

Página 5 de 6

Manejo ACTIVO.

FARMACOLÓGICO:

Paracetamol 1 g cada 8 horas VO.
Quetiapina 25 mg - 25mg - 125 mg VO.
Sertralina 100 mg día VO
Baclofeno 5 mg c/12 hrs VO
Enoxaparina 40 mg/d SC
Uso de ortesis en mano izq y derecha 3h x 1h (uso/descanso)
PEG 17 g en 200 cc de agua c/24 horas

SOS

·Agitación: Lorazepam 2 mg + haloperidol 2,5 mg SOS EV.
Si fiebre 37.8°C pancultivar. Si diarrea tomar PCR C difficile en deposiciones.

Manejo Activo

Int Fuentes / Dr. Sanhueza / Dra Olivares
Medicina Interna

Diagnóstico de Egreso

OTROS TRAUMATISMO Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CABEZA -

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en BCG, hemodinamia estable, afebril, sin apremio ventilatorio. En condiciones de ser trasladado.

Plan Post Alta

INDICACIONES ACTUALES

Régimen: Régimen licuado con líquidos claros asistido 1700 kcal + 65 grs proteína + pescado con puré + suplemento. Asistido, PAUSADO y sentado.

Reposo: semisentado, movilizar y levantar asistido

Oxígeno: SOS para Sat O292%.

Rehabilitación: KNT M y R , FNA, T.O.

HGT AM.

Prevención de caídas y LPP, contención física SOS, aseo bucal cada 8 horas

INVASIVOS: no

Manejo ACTIVO.

FARMACOLÓGICO:

Paracetamol 1 g cada 8 horas VO.
Quetiapina 25 mg - 25mg - 125 mg VO.
Sertralina 100 mg día VO
Baclofeno 5 mg c/12 hrs VO
Enoxaparina 40 mg/d SC
Uso de ortesis en mano izq y derecha 3h x 1h (uso/descanso)
PEG 17 g en 200 cc de agua c/24 horas

SOS

·Agitación: Lorazepam 2 mg + haloperidol 2,5 mg SOS EV.
Si fiebre 37.8°C pancultivar. Si diarrea tomar PCR C difficile en deposiciones.

Manejo Activo

Int Fuentes / Dr. Sanhueza / Dra Olivares

Fecha Epicrisis : 17/06/2023 10:33

Página 5 de 6

Medicina Interna

Indicaciones

Tipo de Reposo : Semisentado, Movilizar Asistido

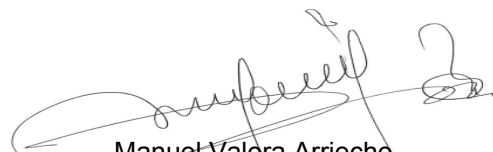
Régimen Alimentario : Licuado

Medicamentos :

Controles

Alejandro Antonio Fuentes Roncag
INTERNO

Bec. Lucas Bec De La Noi Gutierr
Becado/Residente


Manuel Valera Arrieche
Médico Tratante (Staff)